

TEMA 7.10 • NEFROLOGÍA

Glomerulonefritis y Síndrome Nefrítico

PERFIL EUNACOM 1.06.1.011
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Glomerulonefritis y Tipos

Diagnóstico de Glomerulonefritis

- **Sedimento urinario:** Hematuria **dismórfica** (acantocitos) y/o cilindros hemáticos/eritrocitarios.
- Patognomónico de origen glomerular.

Formas Clínicas de Presentación

TABLA 7.10.1: PRESENTACIÓN VS CARACTERÍSTICAS	
PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS
Microhematuria	Solo acantocitos en sedimento (asintomático)
Macrohematuria	Orina visiblemente sanguinolenta (ej: nefropatía por IgA)
Síndrome nefrítico	Tríada: Hematuria + HTA + Edema
GNRP (Rápidamente Progresiva)	GN + ↓ CrCl ≥ 50% en < 3 meses
Síndrome nefrótico impuro	Nefrótico + hematuria / HTA / IRA

Clasificación por Complemento

TABLA 7.10.2: TIPO VS COMPLEMENTO		
TIPO	COMPLEMENTO	ENFERMEDADES
Hipocomplementémicas	↓ C3/C4	GN post-estreptocócica (GNAPE), LES, Crioglobulinemia, GN Mesangiocapilar
Normocomplementémicas	Normal	Nefropatía IgA, Vasculitis, Anti-MBG (Goodpasture)

Clasificación por Inmunofluorescencia (Biopsia)

TABLA 7.10.3: PATRÓN VS ASOCIADO A	
PATRÓN	ASOCIADO A
Lineal	Enfermedad anti-membrana basal (S. Goodpasture)
Granular	Complejos inmunes (GNAPE, LES, IgA)
Pauci-inmune (poca fluorescencia)	Vasculitis (PAM, Granulomatosis con poliangeítis / Wegener)

Tipos Específicos

TABLA 7.10.4: GN VS FRECUENCIA / CLAVE CLÍNICA	
GN	FRECUENCIA / CLAVE CLÍNICA
Nefropatía por IgA (Berger)	GN más frecuente. Hematuria concomitante a infección viral (no días después). Normocomplementémica.
GNAPE (post-estreptocócica)	GN nefrítica más frecuente. 1-2 semanas post-faringitis/impétigo. Hipocomplementémica. Tratamiento: soporte.
GN Mesangiocapilar	Hipocomplementémica. Clínica variable. Puede confundirse con LES o GNAPE.
Crioglobulinemia	Hipocomplementémica. Asociada a VHC. Púrpura palpable + artritis + neuropatía distal en zonas frías.
LES	Hipocomplementémica. GN + clínica sistémica de lupus.
Vasculitis (PAM, Wegener, Churg-Strauss)	Normocomplementémica. Pauci-inmune. Frecuentemente GNRP con falla renal grave.
Anti-membrana basal (Goodpasture)	Síndrome riñón-pulmón: GN + hemoptisis/alveolitis. Patrón lineal.

Estudio de GN

- **Función renal** (clearance, BUN, proteinuria)
 - **Complemento C3/C4**
 - **ANA** (lupus), **ANCA** (vasculitis), **Anti-MBG** (Goodpasture)
 - **Biopsia renal** (casi siempre, salvo GNAPE típica sin falla renal)
- > **Única excepción a la biopsia:** Clínica típica de GNAPE + complemento bajo + SIN falla renal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Niño de 8 años presenta edema, hipertensión y hematuria macroscópica 2 semanas después de una amigdalitis. El complemento C3 está disminuido y la creatinina es de 1.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Glomerulonefritis y Síndrome Nefrítico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de GN: hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos en sedimento urinario.
- Formas de presentación: síndrome nefrítico, micro/macrohematuria aislada, nefrótico impuro, GNRP.
- Síndrome nefrítico: tríada obligatoria de hematuria + hipertensión + edema.
- Hipocomplementémicas: GNAPE, posinfecciosas, lupus, crioglobulinemia, mesangiocapilar.
- Normocomplementémicas: nefropatía por IgA, vasculitis, anti-membrana basal.
- Estudio: función renal + perfil inmunológico (C3/C4, ANA, ANCA, anti-MB) + biopsia renal.
- Biopsia renal en casi todos los casos. Excepción: GNAPE probable sin falla renal grave.
- Si sospecha de GNAPE pero tiene creatinina elevada (ej. 2 o más), se biopsia igual.
- GNAPE: GN con síndrome nefrítico más frecuente. Nefropatía por IgA: GN más frecuente en general.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GLOMERULONEFRITIS Y SÍNDROME NEFRÍTICO)**PREGUNTA 1**

Niño de 8 años presenta edema, hipertensión y hematuria macroscópica 2 semanas después de una amigdalitis. El complemento C3 está disminuido y la creatinina es de 1.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Biopsia renal urgente
- B)** Tratamiento de soporte y observación sin biopsia
- C)** Corticoides en dosis altas
- D)** Iniciar diálisis preventiva
- E)** Iniciar IECA para proteinuria

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años con hematuria dismórfica, hipertensión, edema y creatinina de 5.5 mg/dL. ANCA positivos, complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- B)** Nefropatía por IgA
- C)** Vasculitis de vaso pequeño (GNRP)
- D)** Enfermedad de Goodpasture
- E)** Crioglobulinemia

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes glomerulonefritis es hipocomplementémica?

- A)** Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)
- B)** Vasculitis de vaso pequeño
- C)** Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal
- D)** Glomerulonefritis mesangiocapilar
- E)** Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

RESUMEN: GLOMERULONEFRITIS Y SÍNDROME NEFRÍTICO

La glomerulonefritis se diagnostica con sedimento urinario que muestra hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos/eritrocitarios. Se puede manifestar como síndrome nefrítico (triada de hematuria, hipertensión y edema), microhematuria aislada, macrohematuria, síndrome nefrótico impuro (siempre impuro por la hematuria), falla renal (glomerulonefritis rápidamente progresiva si el clearance cae más del 50% en menos de 3 meses). El tratamiento es tratar la causa, corticoides en algunas (lupus), soporte en otras (GNAPE). El estudio incluye función renal, perfil inmunológico (complemento C3/C4, ANA, ANCA, anti-membrana basal) y biopsia renal. La biopsia se realiza en casi todos los casos, excepto cuando todo apunta a GNAPE y el paciente está sin falla renal grave. Las glomerulonefritis hipocomplementémicas incluyen la postestreptocócica (la más importante), posinfecciosas, lupus, crioglobulinemia y mesangiocapilar. Las normocomplementémicas incluyen nefropatía por IgA, vasculitis y enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal.